

Asociación de Clínicas
y Hospitales Particulares
Asociación de Entidades
Prestadoras de Salud y
Asociación Peruana de Empresas
de Seguros

Manual de Normas de
Facturación,
Auditoría Médica y
Procesos de atención

FEBRERO 2002

**Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares
Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud
Asociación Peruana de Empresas de Seguros**

Finalidad del Manual de Normas de Facturación, Procedimientos y Auditoría Médica

El presente “Manual de Normas de Facturación, Procesos de atención y Auditoría Médica” representa el esfuerzo mancomunado entre la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (ACHP), la Asociación de Entidades Prestadoras de Salud (APEPS), y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) para generar un instrumento técnico – normativo común que regule y unifique criterios de facturación, procesos de atención y Auditoría Médica, en el manejo administrativo de las prestaciones que brindan dichas asociaciones. La Facturación está sujeta a normas y criterios técnicos de utilización correcta y adecuada de los recursos, los cuales tienen base en documentos referenciales de reconocida aceptación médica consensuada.

Todo rubro de facturación no contemplado en el siguiente manual, deberá contar, para su aplicación, con la autorización coordinada entre el Prestador y el Financiador..

INDICE

I. GASTOS DE CLÍNICA

1. Servicios de Clínica

1.1 Ubicación de los Servicios de Clínica	07
1.2 Rubros de facturación de Servicios de Clínica	07
1.3 Descripción de rubros de facturación comprendidos dentro de los servicios de la clínica.	
A. Habitación / Cuarto y alimentación	08
B. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	08
C. Unidad de Quemados	08
D. Cuidados Intermedios (UCIN) o Especiales (UCE)	09
E. Sala de Recuperación	09
F. Sala de partos	09
G. Sala de bebés	09
H. Tópico de Emergencias / Tópico de Procedimientos	09
I. Sala de Operaciones	09
J. Sala de Reposo	10
K. Medicinas / Farmacia	10
L. Uso de instrumental / Aparatos y equipos	11
M. Materiales e insumos	11
N. Personal especializado de apoyo	11
O. Uso de oxígeno	11
P. Mortuorio	11
Q. Uso de ambulancia	11
R. Material protésico	11

2. ESTANCIA HOSPITALARIA

2.1 Admisión de pacientes	12
2.2 Autorización de la atención	12
2.3 Días de hospitalización / Estancia hospitalaria	13
2.4 Ambientes en cirugía ambulatoria.	13
2.5 Estancia no quirúrgica ambulatoria	14
2.6 Tipo de habitación / cuarto.	14
2.7 Alta de pacientes	15

II. NORMAS DE FACTURACIÓN DE HONORARIOS MÉDICOS NO QUIRÚRGICOS.

1. Honorario Médico en la atención ambulatoria	16
1.1 Origen del horario médico no quirúrgico	
1.2 Conceptos incluidos dentro del honorario médico no quirúrgico	
2. Procedimientos médicos	16
2.1 Diagnósticos / Terapéuticos simultáneos	
2.2 Diagnósticos y terapéuticos simultáneos	
3. En el Servicio de Emergencia	17
4. Honorario Médico no quirúrgico en la atención hospitalaria	
4.1 En piso / sala de hospitalización	18
4.2 En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	19
4.3 Interconsultas en Piso / Sala de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y servicios afines	19
4.3.1 Interconsulta de evaluación y sugerencias	19
4.3.2 De Manejo Conjunto	20
4.3.3 De transferencia	20
4.4 Junta Médica	20
4.5 Consulta prolongada	21

III. NORMAS DE FACTURACIÓN DE HONORARIOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS.

1. Honorario médico-quirúrgico	22
2. Procedimiento quirúrgico único	22
3. Procedimientos quirúrgicos simultáneos	22
4. Reintervenciones quirúrgicas	23
5. Complejidad del acto quirúrgico	23
6. Patología quirúrgica imprevista	24
7. Honorarios del Médico Anestesiólogo	24
8. Ayudantes	24
9. Instrumentista	24
10. Obstetriz	24

IV. CONDICIONES ESPECIALES PARA HONORARIOS MÉDICOS	
1. Cardiología intervencionista / Cirugía cardio-vascular	26
2. Gastroenterología	26
3. Hematología y Banco de Sangre	26
4. Traumatología y ortopedia	26
5. Medicina Física y Rehabilitación	27
6. Cirugía de quemados / Tratamiento de quemaduras en pacientes hospitalizados	27
7. Recargo por honorarios médicos y servicios por horario nocturno y feriados.	27
8. Procedimientos sin ubicación dentro del tarifario.	28
9. Honorarios médico – quirúrgicos especiales.	28
V. NORMAS DE FACTURACIÓN SOBRE SERVICIOS DE AYUDA DIAGNÓSTICA O SERVICIOS AUXILIARES.	29
VI. NORMAS DE FACTURACIÓN EN FARMACIA E INSUMOS	30
VII. NORMAS DE AUDITORÍA MÉDICA Y PROCESOS	
1. CONCEPTOS BÁSICOS EN AUDITORIA MEDICA	
– Definición de Auditoria Medica	32
2. CONSIDERACIONES GENERALES	
2.1 En la Historia Clínica	32
2.2 En Servicios Auxiliares	32
2.2.1 Laboratorio	32
2.2.2 Patología	33
2.2.3 Radiografía / Ecografía	33
2.2.4 TAC / RMN / otros estudios de Medicina Nuclear	33
2.2.5 Mapeo Cerebral / EEG digital / Spect cerebral	33
2.3 En el Proceso de la Auditoria Medica	33
2.4 Otras Consideraciones	34
3. NORMAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN	
3.1 ATENCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO	
3.1.1. Hospitalización de Pacientes	34
3.1.2. Autorización	34
3.1.3. Hospitalización en Servicios de Medicina o Especialidades Medicas	
A Criterios de Ingreso	34
B Normas durante el internamiento en Servicios de Medicina o Especialidades Medicas.	34
C Exámenes Complementarios y Procedimientos	35
D Tratamiento	35
E Estancia hospitalaria	35
F Alta de los pacientes	36

3.2	Hospitalización en Unidad De Cuidados Intensivos (UCI):	
3.2.1	Definición	36
3.2.2	Criterios de ingreso	36
3.2.3	Alta de los pacientes de UCI	36
3.3	Sala de Reposo No Quirúrgico	
3.3.1	Definición	36
3.3.2	Criterios De Ingreso	36
3.4	Hospitalización en Servicios Quirúrgicos:	
3.4.1	Criterios De Ingreso	37
3.4.2	Alta De Los Pacientes De Servicios Medico-Quirúrgicos	37
3.5	Del Paciente en Atención Ambulatoria/Emergencia/Preventivo Promocional/Odontología	37
VIII.	GLOSARIO	38
IX.	ANEXOS:	
1.	Auditoria Médica: bases legales, éticas y técnicas	40
2.	Guía de admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos	43
3.	Días de estancia hospitalaria	44
4.	Indicaciones para EEG con Mapeo Cerebral / Spect Cerebral	45
5.	Medicina Hiperbárica	47

I. Gastos de Clínica (Hotelería /Cuarto y Alimentación / Uso de Equipos / Infraestructura / Servicios de Clínica)

1. Servicios de Clínica

1.1. Ubicación de los Servicios de Clínica

Dentro del tarifario se establecen detalladamente los servicios que la Clínica y/o Centro Asistencial brindan de acuerdo al Nivel de Atención de Salud reconocido por el Ministerio de Salud.

1.2. Rubros de Facturación de Servicios de Clínica

Se podrá facturar dentro de este rubro:

- A. Habitación / Cuarto y alimentación
- B. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
- C. Unidad de Quemados
- D. Cuidados Intermedios (UCIN) o Especiales (UCE)
- E. Sala de Recuperación
- F. Sala de partos
- G. Sala de bebés
- H. Tópico de Emergencias / Tópico de Procedimientos
- I. Sala de Operaciones
- J. Sala de Reposo
- K. Medicinas / Farmacia
- L. Uso de instrumental / Aparatos y equipos
- M. Materiales e insumos
- N. Personal especializado de apoyo
- O. Uso de oxígeno
- P. Mortuorio
- Q. Uso de ambulancia
- R. Material protésico

1.3. Descripción de Rubros de Facturación comprendidos dentro de los Servicios de Clínica

A. Habitación / Cuarto y Alimentación

A.1. Incluye uso de cama hospitalaria, ropa de cama, ropa de paciente, atención de médico residente y de enfermería regular, mantenimiento, higiene y limpieza, alimentación completa, incluyendo dietas especiales por indicación del médico, servicios auxiliares de apoyo permanente y termómetro.

A.2. La alimentación no incluye las mezclas nutricionales para nutrición parenteral o enteral despachadas por farmacia.

B. Cuidados Intensivos

– B.1. Además de lo especificado en los numerales A.1. y A.2. incluye atención de enfermería integral, permanente y especializada, uso de equipos de monitoreo (monitor cardíaco), equipo de defibrilación/cardioversión, bomba de infusión, ventilador mecánico. Otros equipos, como pulsoxímetro y capnógrafo son opcionales, sin costo adicional.

B.2. No están incluidos los materiales, insumos y/o aditamentos de uso único y/o desechables utilizados por el paciente.

C. Unidad de Quemados

Entiéndase por Unidad de Quemados al Servicio de atención exclusiva y especializada del paciente quemado, la cual no puede ser brindada en otro servicio de hospitalización.

C.1 Incluye uso de cama hospitalaria, cama especializada Striker, ropa de cama, ropa de paciente, atención del médico residente, uso de equipos de monitoreo, mantenimiento, higiene y limpieza, alimentación completa, incluyendo dietas especiales indicadas por el médico, servicios auxiliares de apoyo permanente y termómetro.

C.2 No está incluido los materiales, insumos, aditamentos de uso único o desechable, utilizados por el paciente.

- D. Cuidados Intermedios (UCIN) o Especiales (UCE)
Para efectos de la facturación tendrá la misma consideración a lo establecido para Cuidados Intensivos.
- E. Sala de Recuperación
E.1. Además de lo establecido en A.1. , incluye atención médica y de enfermería integral, permanente y especializada.
E.2. Están incluidos el uso de equipos de monitoreo en general. Otros equipos, como pulsoxímetro, capnógrafo, defibrilador, son opcionales, sin costo adicional. No están incluidos los materiales, insumos y/o aditamentos de uso único y/o desechables utilizados por el paciente.
E.3 Ser aplicable a pacientes sometidos a anestesia general y anestesia regional, no as en anestesia local.
- F. Sala de Partos
Incluye el uso del local, ropa y vestimenta del personal y del paciente, equipos e instrumental regular para la atencin del parto y del recin nacido, as como el medio de transporte del recin nacido, desde sala de partos a sala de bebs.
- G. Sala de Bebs
Incluye el uso del local, cuna, incubadora en el perodo de adaptacin y personal de enfermera; vestimenta, cuidado, higiene y control de enfermera del recin nacido. No estn incluidos incubadora (fuera del perodo de adaptacin), lmpara de fototerapia, oxgeno, los materiales, insumos y/o aditamentos de uso nico y/o desechables por paciente.
- H. Tpico de Emergencia / Tpico de Procedimientos
H.1. El valor de uso de Tpico de Emergencia / Procedimientos por atencin se establece en el tarifario.
H.2. No estn incluidos los materiales, insumos y/o aditamentos de uso nico y/o desechables por paciente.
- I. Sala de Operaciones
I.1. Incluye equipos de monitoreo (monitor cardiaco, pulsoxmetro, capngrafo), ventilador mecnico,

equipo de anestesia, instrumental quirúrgico, ropa de sala, ropa del paciente y del equipo médico-quirúrgico y material de esterilización. Los componentes señalados en este punto no pueden ser facturados en forma independiente o por separado.

- I.2 El monitor cardíaco se facturará solo en casos de Riesgo Quirúrgico igual o mayor al Grado III, y contando con la presencia del cardiólogo.
- I.3 No incluye personal especializado en cirugía cardiaca con circulación extracorpórea. No incluye medicamentos, suturas, oxígeno ni electrocauterio, así como materiales, insumos y/o aditamentos de uso único y/o desechables por paciente. Tampoco incluye el uso de equipos adicionales no señalados en I.1.
- I.4 Guantes: se cobrará solo un par para el cirujano principal y un par para los ayudantes e instrumentistas especificados en el Tarifario vigente, así como un par para el anesthesiólogo.
- I.5 El uso de sala de operaciones para Cirugía Ambulatoria requiere autorización previa del Financiado.

J. Sala de Reposo para el paciente ambulatorio

- J.1 Según el requerimiento puede tratarse de
 - Sala de Reposo Post Cirugía Ambulatoria o
 - Sala de Reposo no operatorio.
- J.2 Sigue las normas indicadas en los puntos A.1 y A.2
- J.3 La estancia no podrá exceder de un máximo de 8 horas, de lo contrario, se facturará como un día hospitalario.

K. Medicinas / Farmacia

- K.1. Podrán ser facturados todos los medicamentos, materiales de contraste, materiales y/o insumos desechables, y en general, cualquier producto médico especial empleado para la preparación y el tratamiento de los pacientes de correcta utilización y costos convenidos.
- K.2. No se facturará el set inicial de hospitalización (jabón, esponjas, papel higiénico, hoja de afeitar, termómetro).

L. Uso de Instrumental / Aparatos y Equipos

- L.1. El concepto uso de equipo incluye el valor de reposición, desgaste, mantenimiento, renovación, pérdida tecnológica y los materiales e insumos fijos propios de la manipulación del mismo.
- L.2. No están incluidos los materiales, insumos y/o aditamentos de uso único y/o desechables por paciente.
- L.3. No se facturará el uso de equipos diagnósticos generales que no estén incluidos en el Tarifario vigente (pantoscopio, tensiómetro, estetoscopio, fetoscopio, electrocardiógrafo, ecocardiógrafo, etc.), los mismos que quedan incluidos dentro del valor de la atención y/o procedimiento que los utilice.

M. Materiales e Insumos

Podrán facturarse los materiales e insumos médicos de uso por vez y/o desechables por paciente.

N. Honorario de Personal Especializado de Apoyo

Prevía autorización del Financiador, se facturará adicionalmente el cuidado por personal especializado de apoyo en relación con la condición del paciente y la indicación médica.

O. Uso de Oxígeno

Se facturará según unidad de consumo establecida dentro del tarifario.

P. Mortuorio

El valor se establecerá en el tarifario. Su facturación deberá ser autorizada por el Financiador.

Q. Uso de Ambulancia

Solo se facturará el valor de uso de ambulancia por traslado y/o transferencia del paciente de su domicilio a la Clínica / Centro Asistencial o viceversa. Este servicio requiere aprobación previa del Financiador.

R. Material Protésico

R. 1 Quedan comprendidos dentro de este concepto: endo y/o exoprótesis de cualquier tipo, elementos de

fijación interna y/o externa, de osteosíntesis, clavos, placas, tornillos, alambres de traumatología y ortopedia, marcapasos, válvulas, injertos y/o parches arteriales, y en general cualquier material y/o aditamento de uso interno y/o externo, temporal y/o definitivo, de reemplazo, substitución parcial y/o total o apoyo de estructuras anatómicas y/o funcionales.

R. 2 . La cobertura del material protésico requerido deberá contar, con autorización previa del Financiador.

2. Estancia Hospitalaria

2.1 Admisión de Pacientes

La facturación consignará los gastos por concepto de atención en el punto donde se originó el servicio (consultorio externo, emergencia) y en el servicio de destino (hospitalización, UCIG, Sala de Operaciones) considerando la estancia hospitalaria de 24 horas, siempre y cuando la permanencia en el servicio sea igual o superior a 8 horas. Los ambientes físicos (consultorio externo, emergencia), no son facturables en los casos de que la atención derive a hospitalización.

2.2 Autorización de atención: Carta de Garantía / Código de Autorización Previa / Programa

Entiéndase por Carta de Garantía / Código de Autorización Previa / Programa, a los documentos emitidos por el Financiador, donde autoriza la prestación de salud hospitalaria al proveedor, en base a la información proporcionada por éste.

Toda hospitalización programada deberá contar con la autorización respectiva, y la no programada deberá ser comunicada y solicitada al Financiador dentro de las 24 horas útiles posteriores a la admisión.

Toda autorización de atención está sujeta a Auditoría Médica.

2.3 Días de Hospitalización/ Estancia Hospitalaria

2.3.1 El día del ingreso del paciente se reconoce al valor completo del día siempre que éste se haya producido hasta las 12:00 horas del mismo. Después de las 12:00 horas se considerará como ingresado el día siguiente.

2.3.2 El día de egreso no se facturará independientemente de la hora del alta médica, exceptuando en los siguientes casos:

- Fallecimiento después de las 12:00 horas
- En abandono, retiro, o alta voluntaria del paciente: facturación sujeta a auditoría.

2.3.3 La estancia hospitalaria sin justificación médica, solicitada formalmente por el paciente, será asumida por él.

2.3.4 La estancia hospitalaria prolongada no aprobada por el Financiador, no será facturada a éste.

2.4 Ambientes en Cirugía Ambulatoria

2.4.1 Uso de ambientes en Cirugía Mayor Ambulatoria.

Se entiende por Cirugía Mayor Ambulatoria, aquella cirugía que cumple los criterios de uso de Sala de Operaciones, indicado en el punto 1.1.5 del presente Manual.

Podrán ser facturados los siguientes conceptos:

- Estancia preoperatoria (incluye preparación preoperatoria).
- Sala de Recuperación post operatoria inmediata: hasta 6 horas.
- Sala de Reposo Post-operatorio

2.4.2 En cirugía Mayor ambulatoria con anestesia general o regional, se facturará la estancia pre- y posquirúrgica cumplida por el paciente de acuerdo a lo establecido en el tarifario. En los casos que por complicaciones del paciente, se determine su permanencia hospitalaria se procederá a facturar como intervención programada con hospitalización regular. Esto conllevará la regularización de las condiciones autorizadas inicialmente.

2.4.3 Uso de Ambientes en Cirugía Menor

Ambulatoria.

Se entiende por Cirugía Menor Ambulatoria, aquella que no cumple los criterios de uso de Sala de Operaciones.

Se podrá facturar:

- Tópico de procedimientos.
- Sala de Reposo post operatorio, en caso que el paciente haya requerido sedación.

2.5 Estancia no quirúrgica ambulatoria.

Involucra todos aquellos tratamientos y procedimientos diagnósticos o terapéuticos que por su naturaleza requieren de corta estancia en la clínica, en la Sala de Reposo No Operatorio, pero que sin embargo no ameritan una estancia hospitalaria de 24 horas.

La estancia no quirúrgica ambulatoria no podrá ser mayor a 08 horas, facturándose por todo concepto las horas cumplidas por el paciente, de acuerdo a lo establecido en el tarifario, o en su defecto se facturará como máximo el equivalente a 01 día de habitación / cuarto, salvo en los casos que por complicaciones del paciente, se determine su permanencia hospitalaria, procediéndose a facturar como intervención programada con hospitalización regular. Esto último, conllevará a la regularización de las condiciones autorizadas inicialmente.

2.6 Tipo de Habitación / Cuarto

2.6.1 La Clínica facturará el valor de la habitación/cuarto que ocupe el paciente según lo autorizado por el financiador.

2.6.2 Solo se podrá facturar el uso de un tipo de habitación/cuarto por día. Se facturará el valor diario de habitación/cuarto efectivamente ocupado teniendo como periodo mínimo 8 horas de estancia hospitalaria.

2.6.3 Cuando el paciente requiera un tipo de habitación/cuarto diferente al de la cobertura de su póliza/plan/programa, previa autorización se facturará la diferencia a su financiador, o en su defecto será asumido directamente por el paciente previa autorización expresa y escrita del mismo.

2.6.4 Las transferencias de habitaciones/cuartos a solicitud del paciente deberán acreditarse con la firma del

solicitante quien asumirá la diferencia económica que ésta genere.

2.7 Alta de Pacientes

No se considerará para efectos de la facturación el día del alta hospitalaria, encontrándose concordado este artículo con el numeral 2.3.2.

II. Normas de Facturación de Honorarios Médicos No Quirúrgicos

1. Honorario Médico en la Atención Ambulatoria

1.1 Origen del Honorario Médico no Quirúrgico

El honorario médico en la atención ambulatoria deviene de la consulta y los procedimientos médicos diagnósticos y/o terapéuticos especializados que éste realice directamente en beneficio de su paciente.

1.2 Conceptos incluidos dentro del Honorario Médico no Quirúrgico

Para efecto de la facturación :

1.2.1 La consulta ambulatoria.

1.2.2 La consulta médica estará incluida en el valor del procedimiento médico cuando lo consigne específicamente el tarifario.

2. Honorario en Procedimientos Médicos:

2.1 Procedimientos Diagnósticos Simultáneos / Procedimientos Terapéuticos Simultáneos

Aplicable cuando se realicen dos o más procedimientos diagnósticos/terapéuticos en forma simultánea por el mismo profesional médico sobre la misma zona anatómica o lugar de abordaje, para efectos de facturación se aplicará el 100 % del valor al procedimiento de mayor costo, salvo excepciones, previamente concordadas entre Proveedor y Financiador, en que se aplicará la norma de 100% de la mayor, más 50% de la siguiente y 25% de las subsiguientes. Este acuerdo será vigente para el caso en particular. No es válido para los casos expresamente contemplados en el Tarifario.

Cuando se realicen por zona anatómica o vía de abordaje distintas se aplicará el 100% del valor correspondiente a cada uno, salvo que en el tarifario se consigne con un código específico el mismo procedimiento indicado en afecciones bilaterales y/o múltiples.

2.2 Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos Simultáneos

Cuando se realice un procedimiento terapéutico a continuación o después de un procedimiento diagnóstico aprovechando la misma vía de abordaje, para efectos de facturación se aplicará el 100% del procedimiento terapéutico.

Cuando se ejecuten procedimientos sucesivos diagnósticos y terapéuticos simultáneamente conducidos por un mismo especialista se procederá a englobar los mismos procedimientos diagnósticos y terapéuticos según el numeral II-2.1.

3. Honorario Médico No Quirúrgico en el Servicio de Emergencia

- 3.1 El honorario médico en el Servicio de Emergencia debe sujetarse a las mismas normas de la atención ambulatoria.
- 3.2 Para efectos de la facturación se tendrán en consideración las siguientes situaciones especiales:
 - A. Cuando por razones de la gravedad o complejidad del caso concurren dos o más profesionales médicos de diferentes especialidades en la asistencia del paciente, cada profesional facturará el 100 % del honorario que le corresponde individualmente. La condición que generó esta excepción deberá estar debidamente consignada en la historia clínica del paciente.
 - B. Si adicionalmente a ello, alguno o todos los profesionales médicos, debido a la gravedad o complejidad del caso, realizaran algún procedimiento

diagnóstico y/o terapéutico se facturará el 100% del valor que le corresponda por el procedimiento realizado.

- C. Si posteriormente a su atención, el Médico Emergencista o el especialista principal determinan que la situación de salud del paciente requiere hospitalización, el especialista receptor, siempre y cuando haya intervenido en la evaluación del caso en el servicio de Emergencias, facturará sus honorarios según se establece en el acápite correspondiente a honorarios médicos en la atención hospitalaria o médico-quirúrgicos según corresponda, es decir, el médico tratante no facturará los honorarios de atención de emergencia.
- D. El Médico Emergencista podrá facturar el equivalente a una consulta por su participación en la atención del paciente en emergencia, siempre y cuando se demuestre el acto médico. No se podrá facturar honorarios del médico emergencista cuando su función es sólo de triaje.
- E. En procedimientos simultáneos diagnósticos y/o terapéuticos conducidos por el mismo médico se seguirán los mismos criterios de facturación que rigen para las atenciones ambulatorias (numerales del II-2.1 al II-2.2).

4. Honorario Médico No Quirúrgico en la Atención Hospitalaria

Para efectos de la facturación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

4.1 En Piso / Sala de Hospitalización

- A. Rutinariamente en Sala de Hospitalización se facturará el valor correspondiente a 2,5 consultas durante los tres (03) primeros días de hospitalización contados a partir de su ingreso, en virtud de lo que representa el acto médico durante los momentos críticos iniciales y que sustenta la hospitalización del paciente.
- B. Los días subsiguientes hasta el día del alta inclusive, tendrán el valor correspondiente a 1,5 consultas.
- C. Cuando el médico tratante realice procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, estos serán facturados sin afectar el valor de los honorarios que rutinariamente correspondan por la hospitalización .
- D. La historia clínica deberá tener registrada la evolución y órdenes médicas diarias, escritas o refrendadas por el

médico tratante. El no registro de éstas, podrá llevar al no reconocimiento de los honorarios.

4.2 En la Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.)

- A. En toda Unidad de Cuidados Intensivos se incluye la atención permanente por un Médico Intensivista.
- B. En toda Unidad de Cuidados Intensivos los honorarios médicos tendrán el valor correspondiente a 4,5 consultas por día, durante los tres primeros días, de ahí en adelante por cada día adicional hasta el alta del servicio tendrán el valor correspondiente a 3,5 consultas. Estas consultas incluyen los honorarios del médico tratante y el Médico Intensivista. Incluye la consulta en el Servicio de Emergencia siempre y cuando el médico tratante haya evaluado al paciente en dicho servicio.
- C. Cuando el médico tratante o el Intensivista realice procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, estos serán facturados sin afectar el valor de los honorarios que rutinariamente correspondan por la hospitalización.
- D. En la Unidad de Cuidados Intermedios tendrá el valor de 3 consultas por día, durante los tres primeros días y dos consultas por día, los días subsiguientes hasta el alta.
- E. El médico interconsultado podrá facturar a razón de 1,5 consultas por visita por día en UCI

4.3 Interconsultas en Piso / Sala de Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y servicios afines

Existen diversos tipos de Interconsulta:

- De Evaluación y Sugerencias
- Manejo Conjunto
- Transferencia
- Traslado

4.3.1 Interconsulta de Evaluación y sugerencias:

- A. En el caso de Interconsulta de evaluación y sugerencias, tendrá el valor correspondiente a 1,5 consultas y deberá

ser solicitado formalmente por el médico tratante principal o encargado del caso.

- B. El número de interconsultas de evaluación y sugerencias está determinado por las necesidades de evaluación del caso y la respuesta terapéutica del paciente. En todo caso, no deberán ser superiores a dos por especialidad, y en UCIG / UCE no deberán ser superiores a tres por especialidad.

4.3.2 Manejo Conjunto

- A. El manejo conjunto es solicitado por el médico Tratante.
- B. Todo Manejo Conjunto deberá ser informado y sustentado al Financiador, para su aprobación.
- C. Los especialistas que concurren en el manejo conjunto de un determinado paciente facturarán a razón de dos consultas por día, los tres primeros días de estancia hospitalaria y luego 1,5 consultas diarias, independientemente del Servicio donde se encuentre hospitalizado el paciente, y en relación al día de internamiento.

4.3.3 Transferencia de Pacientes

- A. El médico que transfiere procederá a dar de alta de su especialidad al paciente y facturará como se establece en los numerales anteriores respecto del honorario médico en paciente hospitalizado (1.5 consultas el día de alta). El médico receptor facturará al final de su atención como una hospitalización común siguiendo las normas de facturación, según el día hospitalario de recepción del paciente.
- B. En el caso de traslado de pacientes a otra institución, al igual que en la transferencia se procederá a dar de alta al paciente y se facturará la atención hasta ese día inclusive.

4.4 Junta Médica

- A. Será solicitada formalmente por el médico tratante principal o encargado del caso quien la presidirá. Toda Junta Médica deberá ser informada y sustentada al Financiador para su aprobación.

- B. Tendrá el valor de 2 consultas para cada uno de los médicos que la integren excepto para el médico tratante quien facturará una (01) consulta adicional.
- C. El Acta de la Junta Médica deberá registrarse en la Historia Clínica, firmada y sellada por todos los Médicos participantes.

4.5 Consulta Prolongada

- A. Excepcionalmente se podrá facturar por consulta prolongada, cuando la gravedad del caso exige la permanencia del médico al lado del paciente, durante varias horas.
- B. Corresponde al valor de 1,5 consultas por hora.
- C. Requiere adjuntar Informe Médico adicional, y deberá estar registrada en la Historia Clínica.

III. Normas de Facturación de Honorarios Médicos Quirúrgicos

1. El honorario médico quirúrgico incluye:

- La consulta diagnóstica de la patología quirúrgica siempre y cuando se haya producido en el Servicio de Emergencia.
- La solicitud y evaluación de los exámenes y riesgo pre-quirúrgico.
- El control preoperatorio inmediato.
- El planeamiento de la técnica quirúrgica.
- El procedimiento quirúrgico realizado.
- Las consultas de control postquirúrgico inmediato en Sala de Recuperación
- Las consultas de control postquirúrgico durante la hospitalización hasta el décimo día.
- Las indicaciones médicas preparatorias para la cirugía y durante la hospitalización post quirúrgica.
- Las curaciones rutinarias de la herida operatoria durante la estancia hospitalaria.
- Las reintervenciones quirúrgicas por la misma patología, o sus complicaciones, dentro de los 10 primeros días de la intervención original.

2. Procedimientos quirúrgicos únicos:

Se reconocerán bajo este rubro todas aquellas intervenciones quirúrgicas únicas o compuestas por sub-procedimientos orientadas a una sola patología quirúrgica ubicada en una misma zona topográfica quirúrgica, de manera que determinen un solo tiempo de cirugía, independientemente del punto de abordaje o cavidad anatómica. Para la facturación de los honorarios médicos se considerará sólo el procedimiento de mayor valor.

3. Procedimientos Quirúrgicos Simultáneos.

- A. El honorario quirúrgico por dos o más procedimientos / intervenciones realizadas por el mismo cirujano orientadas al tratamiento de una y/o varias patologías quirúrgicas dentro de una o varias zonas o topografías quirúrgicas a través de un mismo punto de abordaje o cavidad anatómica corresponde al 100 % del procedimiento quirúrgico de mayor valor, salvo excepciones debidamente comprobadas, en que se aplicará la norma 3.B.

- B. Los Honorarios por las Intervenciones quirúrgicas efectuadas simultáneamente por un cirujano, mediante diferentes incisiones, serán los del 100 % de la intervención mayor, más 50% de la segunda intervención, más 25% de cada una de las siguientes intervenciones que hubieran
- C. Los Honorarios por las intervenciones quirúrgicas efectuadas simultáneamente por cirujanos de diferente especialidad serán los correspondientes al 100% de cada una de la intervenciones, debiéndose aplicar los porcentajes establecidos en los acápite anteriores cuando concurrieran dos o más procedimientos realizados simultáneamente.
- D. Este concepto también rige para cirugías de problemas bilaterales o de múltiple localización excepto en todos aquellos procedimientos dentro del tarifario donde se precise su condición de bilateral o múltiple.

4. Reintervenciones quirúrgicas:

- A. Los honorarios por reintervenciones quirúrgicas, efectuadas por el mismo cirujano, debido a complicaciones de la primera intervención serán:
 - dentro de los primeros diez días de la intervención original, no se facturará la reintervención.
 - De 11 a 30 días después de la reintervención original, se facturará el 50% de la reintervención efectuada.
 - Después de los 30 días, se facturará el 100% de la reintervención efectuada.

B. Los honorarios por reintervenciones quirúrgicas, efectuadas por el mismo cirujano, no comprendidos en el inciso A, serán sometidos a evaluación por Auditoría Médica para su facturación.

C. Los honorarios por reintervenciones quirúrgicas, efectuadas por un Cirujano de diferente especialidad al Cirujano original, independientemente del tiempo transcurrido desde la intervención original, corresponderá al 100% de la intervención que se efectúe.

5. Complejidad del Acto Quirúrgico:

Los honorarios quirúrgicos podrán ser incrementados hasta en un 25% en aquellos casos con complicaciones severas y/o estado general comprometido que requieran intervención quirúrgica inusualmente prolongada, sujeto a informe médico que lo sustente.

6. Patología quirúrgica imprevista:

Las patologías quirúrgicas no previstas inicialmente por el cirujano en la orden de hospitalización, que formen parte de los hallazgos consignados en el reporte operatorio, se facturará de acuerdo al inciso 3.B, siempre y cuando tengan indicación quirúrgica. Debe acompañarse resultados de Anatomía Patológica, cuando así lo indique en el tarifario.

7. Honorario del Médico Anestesiólogo

7.1 El honorario del anestesiólogo incluye: la evaluación y tratamiento preanestésico del paciente, atención médica en sala de operaciones, procedimientos anestésicos, y la estabilización de los parámetros vitales postquirúrgica. La evaluación preanestésica debe estar registrada en la Historia Clínica obligatoriamente.

7.2 El honorario del anestesiólogo será el equivalente al 30% del honorario total del cirujano principal, sea cirugía convencional o laparoscópica. En ningún caso el honorario podrá ser menor al equivalente a 15 unidades del Tarifario Unico.

8. Ayudantes

8.1 El número de ayudantes hábiles que se puede facturar estará consignado dentro del tarifario.

8.2 Excepcionalmente se podrá facturar un número mayor de ayudantes cuando el tipo de intervención quirúrgica o las particularidades del paciente así lo exijan, hecho que deberá estar debidamente documentado en el reporte operatorio.

8.3 Los honorarios por ayudantía serán facturados de acuerdo al siguiente cuadro de distribución:

- Primer Ayudante 25 % del Honorario del Cirujano
- Otros Ayudantes 15 % del Honorario del Cirujano

9. Instrumentista

El honorario rutinario del Instrumentista será facturado a razón del 6 % del Honorario del Cirujano.

10. Obstetriz

10.1 Los Honorarios de la Obstetriz en Parto Vaginal serán equivalentes al 8 % de los honorarios del Obstetra.

- 10.2 Los honorarios de la Obstetrix en trabajos de Parto que terminan en parto por Cesárea, por razones de emergencia, serán equivalentes al 4 % de los honorarios del Obstetra.

IV. Condiciones Especiales a considerar para la Facturación de los Honorarios Médicos

1. Cardiología Intervencionista / Cirugía Cardiovascular

- 1.1 En los procedimientos de Cardiología Intervencionista que requieran Ayudante, Instrumentista o ambos, se facturará según se indique en el tarifario.
- 1.2 En cirugía cardiaca abierta se facturará por 01 Perfusionista el 15% del honorario del cirujano cardio-vascular.

2. Gastroenterología

Los procedimientos endoscópicos diagnósticos y /o terapéuticos no incluyen el valor de la consulta, salvo los expresamente indicados dentro del tarifario. Tampoco los materiales e insumos ni el uso del equipo los que serán facturados aparte.

3. Hematología y Banco de Sangre

La calificación de la sangre y los estudios de banco de sangre proveniente de donantes heterólogos o autólogo serán asumidos directamente por el paciente salvo indicación expresa del financiador. .

4. Traumatología y Ortopedia

- 4.1 En caso de Luxo – Fracturas se facturará el procedimiento de mayor valor al que se le adicionará el 30 % por complejidad.
- 4.2 En los procedimientos que requieran de injerto óseo se adicionará el 50 % como concepto de obtención del mismo.
- 4.3 El tratamiento simultáneo de múltiples lesiones tendinosas será facturado a razón de 100% del primer tendón, 50 % del segundo y 25 % de los sucesivos,

5. Medicina Física y Rehabilitación

Se podrá facturar una consulta para evaluación preliminar y la planificación de las sesiones, y una consulta final para la evaluación del resultado obtenido, más las sesiones correspondientes realizadas. Lo anterior es válido tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. Las sesiones realizadas deben estar registradas en la Historia Clínica para su facturación.

6. Cirugía de Quemados / tratamiento de las quemaduras en pacientes hospitalizados

- 6.1 El Honorario comprende una parte fija donde están incluidas las consultas y evaluaciones médicas durante la hospitalización, la planificación quirúrgica y las curaciones rutinarias, hasta por 20 días de internamiento. Los procedimientos reconstructivos y las limpiezas o curaciones quirúrgicas realizadas en Sala de Operaciones se facturarán adicionalmente.
- 6.2 A partir del día vigésimoprimeros (21) y en adelante, se podrá facturar el valor de 01 consultas como cualquier paciente, hasta el alta.
- 6.3 Al alta, el manejo del paciente seguirá las pautas planificadas y se facturará como se indica dentro del tarifario. Los procedimientos que se realicen ambulatoriamente no incluirán el valor de la consulta salvo esté consignado dentro del tarifario.
- 6.4 Se podrá facturar hasta 25 % adicional por concepto de compromiso o complejidad cuando la quemadura afecte zonas especiales como región facial, región ocular, pabellones auriculares, boca, nariz, región genital y/o flexuras y/o articulaciones.

7. Recargo en Honorarios Médicos y Quirúrgicos por Horario Nocturno y Feriados:

- a. **Horario Nocturno (entre las 20:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente)**, tendrá un recargo del 20 % sobre la tarifa diurna

- b. Días feriados (sábados desde las 14:00 horas , 24 horas domingo y feriados), tendrá un recargo del 20 % sobre la tarifa diurna.
- c. Este recargo es válido para:
- Las operaciones realizadas de emergencia, debidamente comprobadas, independientemente de la hora de ingreso del paciente, siempre que el estado del paciente y su evolución impidan la postergación de la intervención, y obliguen a su realización inmediata.
 - Las consultas originadas por emergencias del paciente, debidamente documentadas, y se aplican en la Emergencia y Hospitalización de la Clínica.

8. Procedimientos sin ubicación dentro del tarifario

Todo procedimiento nuevo, no ubicado dentro del tarifario vigente, deberá ser comunicado por el Proveedor al Financiado, para determinar si tiene o no cobertura, y asignar la unidad que le corresponda, quedando establecido por consenso. Esto será válido para el caso en particular.

9. Honorarios Médico quirúrgicos especiales:

- Cirugía Laparoscópica / Videoendoscópica / Toracoscópica
- Los Honorarios del Equipo Quirúrgico tendrán un recargo del 50% sobre la cirugía convencional.

V. Normas de facturación sobre Servicios de Ayuda Diagnóstica o Servicios Auxiliares: Laboratorio / Rayos X / Ecografía / Tomografía / Resonancia Magnética / Medicina Nuclear / Gammagrafía

1. Los Servicios de Ayuda Diagnóstica o Servicios Auxiliares definidos como todos aquellos que no requieren del concurso inmediato y permanente del médico para realizarse y que cuentan con el apoyo de personal técnico capacitado, se refieren exclusivamente a los indicados en el presente título.
2. La facturación de los Servicios de Ayuda Diagnóstica o servicios auxiliares guardará relación con los procedimientos realizados para la detección de la (s) patología(s) que sean materia de estudio clínico, considerando el valor individual por separado de cada una de ellas según se establece en el tarifario.
3. La solicitud de repetición de pruebas de laboratorio o de exámenes de ayuda diagnóstica por defecto, pérdida o error, atribuible al proveedor, deberá repetirse sin costo alguno.
4. Sólo en el caso de Ecografía se podrá facturar el 20% adicional por concepto de atención en horario nocturno y/o feriado, cuando así se haya producido el servicio, pues para todo concepto se considerará como honorario médico, no obstante estar incluido en este capítulo.

VI. Normas de facturación de gastos de Farmacia e Insumos

1. Los fármacos prescritos guardarán relación con la(s) patología(s) declarada(s) en la historia clínica del paciente.
2. Se deberá trabajar con listado de medicamentos proporcionado por el Proveedor, respecto al cual, el Financiador deberá proporcionar un listado de los medicamentos que no se encuentran cubiertos, así como también, las excepciones del caso. Toda modificación al respecto deberá ser formalizada por escrito antes de su aplicación, en cuyo defecto queda establecida su cobertura.
3. Es responsabilidad del Proveedor el conocer y respetar el listado de medicamentos y productos no cubiertos por el Financiador. Después de prescrito el medicamento, las consultas al Financiador, deben ser excepcionales. Es responsabilidad del Financiador el que sus afiliados conozcan que existen medicamentos excluidos, y sus excepciones.
4. Se evitará la prescripción de medicamentos excluidos o no cubiertos por el Financiador. De requerirse éstos por indicación médica, previa información, serán facturados directamente al asegurado. Esto rige también para los fármacos nuevos o de reciente introducción que no se encuentren dentro del petitorio.
5. Se evitará la Polifarmacia, de manera que si se prescriben dos o más medicamentos de efectos terapéuticos similares para una o varias enfermedades, deberá acompañarse de una nota explicativa, de lo contrario se solicitará un informe médico ampliatorio.
6. El periodo máximo de medicación que se puede indicar en pacientes agudos o subagudos atendidos en el Servicio de Emergencias y/o ambulatoriamente por Consultorio Externo, no deberá exceder lo requerido por el paciente para 7 días de acuerdo a la posología prescrita por el médico tratante.
7. El periodo máximo de medicación que se puede indicar en pacientes crónicos no deberá exceder lo requerido por el paciente para 30 días de acuerdo a la posología prescrita por el médico tratante.

8. Los periodos de medicación adicionales a lo establecido en los numerales anteriores deberán ser autorizados previamente de manera formal por el financiador, y sustentado por el Médico tratante.
9. En pacientes hospitalizados, la medicación al alta deberá prescribirse por un periodo igual o equivalente al lapso que transcurrirá hasta la próxima cita o control con el médico tratante. En todo caso no podrá exceder a 14 días de acuerdo a la posología prescrita por el médico tratante.
10. Las prescripciones de fórmulas magistrales y/u oficinales se basarán en el petitorio respectivo, el mismo que mencionará el o los principios activos que las componen.
11. En caso de incumplimiento de las normas anteriores, motivará la devolución del expediente para su aclaración, la cual estará sujeta a Auditoría Médica.
12. En caso de procedimientos o Intervenciones quirúrgicas:
Todo material, insumo, medicamento, instrumental desechable, de uso exclusivo por vez utilizado en beneficio diagnóstico y/o terapéutico del paciente será facturado aparte del procedimiento bajo el rubro farmacia, salvo en aquellos procedimientos e Intervenciones quirúrgicas que se consigne específicamente dentro del tarifario.

VII. NORMAS DE AUDITORIA MEDICA Y DE PROCESOS DE ATENCIÓN

1. CONCEPTOS BÁSICOS EN AUDITORIA MEDICA DEFINICIÓN DE AUDITORÍA MÉDICA:

- Es la revisión ordenada y sistemática de los procesos médico-administrativos de las diversas prestaciones de salud otorgadas en el sistema, con el objetivo de vigilar la calidad de la atención, el uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, así como minimizar el riesgo moral (Uso del sistema de manera indebida, excesiva, no justificada o fraude).
Todo ello en el marco de los convenios contractuales establecidos, las leyes vigentes y el Código de Ética del Colegio Médico del Perú.
- Las funciones del Médico Auditor se extienden también a la verificación del cumplimiento de las normas de facturación y del proceso de atención al asegurado. (condicionados de pólizas, convenios, porcentaje de descuentos, exclusiones, etc.).

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 EN LA HISTORIA CLÍNICA:

Considerando que es un documento médico-legal, debe consignar información veraz, precisa y oportuna.

Debe incluir por lo menos el siguiente registro:

- Fecha y hora de atención
- Nombre y edad del paciente
- Antecedentes: fechas de diagnóstico y tratamientos recibidos
- Motivo de consulta y tiempo de la enfermedad
- Examen clínico
- Impresión diagnóstica o planteamiento de problemas
- Plan diagnóstico (registrar los exámenes auxiliares solicitados)
- Plan terapéutico: incluye anotación de medicamentos prescritos (dosis, tiempo de cumplimiento), dieta, indicación de terapia física, etc.
- Fecha de próxima evaluación.
- Epicrisis en los casos de hospitalización
- Firma y sello del médico tratante

Epicrisis:

- Se adjuntará a toda factura rutinariamente una copia de la epicrisis de la Historia Clínica y de las interconsultas.

2.2 EN SERVICIOS AUXILIARES

2.2.1 Laboratorio:

- Hemocultivos con un máximo de 03, salvo casos debidamente justificados.

- Colesterol y/o triglicéridos, pero no lípidos totales ni lipidograma electroforético. En forma rutinaria.
- Electrolitos: evitar solicitud no justificada.
- Los exámenes reumatológicos deben ser solicitadas selectivamente, y en forma pertinente según presunción diagnóstica.
- Parasitológico seriado: máximo tres muestras

2.2.2 **Patología:**

- Se requerirá obligatoriamente el informe anátomo patológico, en todas las operaciones y procedimientos que están señalados en el tarifario convenido de la Clínica con letra "P", después del código de la operación o del procedimiento.
- El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la suspensión o reducción del pago de honorarios quirúrgicos, salvo clara justificación escrita.

2.2.3 **Radiografía / Ecografía:**

- Radiografía de tórax lateral sólo en los casos indicados (no rutinario)
- Evitar diferentes estudios por imágenes o endoscopías de la misma región anatómica.
- Solicitar de acuerdo a la presunción diagnóstica.

2.2.4 **Tomografía Axial Computarizada (TAC), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y otros estudios con recursos de Medicina Nuclear:**

- Con solicitud de autorización previa al Financiador y justificación del pedido, salvo urgencias.

2.2.5 **El Mapeo Cerebral / EEG digital/ Spect cerebral**

- Con solicitud de autorización previa por la compañía y justificación del pedido
- Ver el anexo correspondiente.
- La Cobertura de estos Exámenes auxiliares está sujeta a los condicionados del Plan de Salud.

2.3 **NORMAS EN EL PROCESO DE LA AUDITORIA MEDICA.**

- La clínica debe presentar la información adecuada solicitada por el médico Auditor, sea en medio impreso o magnético. Así mismo, debe brindar las facilidades para la realización de la auditoría médica completa y oportuna, en cualquiera de sus tipos.
- Debe existir una correcta comunicación entre médicos auditores de los Proveedores y Financiadores, respetando el escalamiento del nivel de solución de no conformidades, según acuerdo.
- El Financiador procederá a realizar la auditoría en los casos médico quirúrgicos necesarios, para determinar la cobertura o no, para efectos de facturación.
- Los informes presentados por el médico tratante como respuesta sustentatoria deben ser de carácter científico, de consenso y no justificaciones de juicio individual. Del mismo modo, se debe cumplir esta norma para las observaciones realizadas por el médico auditor del financiador.

2.4. OTRAS CONSIDERACIONES:

- Los casos de pacientes terminales o en condiciones patológicas irreversibles deben ser evaluados bajo los más altos principios y consensos de orden ético y moral, por un comité médico conformado por médicos del Proveedor y del Financiador.

3. NORMAS EN EL PROCESO DE ATENCIÓN**3.1 DEL PACIENTE HOSPITALIZADO****3.1.1 HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES**

- El paciente podrá ingresar a los Servicios de Hospitalización desde Emergencia, Consultorio Externo o con orden del médico de la red periférica autorizada. Se aceptará en forma excepcional la vía Consultorio Externo → Emergencia → Hospitalización.

3.1.2 AUTORIZACION DE LA HOSPITALIZACION

- Con la orden escrita del médico tratante, se solicitará la autorización del Financiador, quien responderá emitiendo la Carta de Garantía/Autorización/Programa, de ser pertinente.
- Para hospitalizaciones programadas, la Carta de Garantía/Autorización/Programa deberá solicitarse en el plazo pactado. El asegurado se hospitalizará después de emitida y registrada la Carta de Garantía/Autorización/Programa.
- Para hospitalizaciones por emergencia, la autorización deberá tramitarse durante las 24 primeras horas hábiles desde el ingreso a la clínica.
- En caso de requerirse una ampliación de la Carta de Garantía/Autorización/Programa, la clínica deberá solicitarla al Financiador antes del alta del paciente.

3.1.3 HOSPITALIZACION EN SERVICIOS DE MEDICINA O ESPECIALIDADES MEDICAS:**A. CRITERIOS DE INGRESO**

- Pacientes que requieren tratamiento parenteral en forma endovenosa más de dos veces por día.
- Pacientes que por la enfermedad de fondo no puedan deambular (postrados agudos)
- Estado general comprometido, que limita la actividad física.
- Características de la enfermedad de fondo, necesidad de un diagnóstico urgente o que no pueda ser realizado en forma ambulatoria.
- Indicación médica justificada con informe, previa autorización del Financiador.

B. NORMAS DURANTE EL INTERNAMIENTO EN SERVICIOS DE MEDICINA O ESPECIALIDADES MÉDICAS:

- La confección de la historia clínica, el diagnóstico de ingreso, el plan de trabajo, la solicitud de servicios auxiliares de primera línea en relación al diagnóstico, la formulación de interconsultas pertinentes y el inicio del tratamiento se efectuarán de manera inmediata al ingreso del paciente.

- Adicionalmente, en las primeras 24 horas deberá realizarse o al menos programarse los procedimientos diagnósticos y / o terapéuticos que forman parte del plan de trabajo y se evaluarán los primeros resultados.
- Durante el segundo día se debe realizar un análisis de lo actuado y si es necesario replantear el plan diagnóstico y terapéutico.
- El médico tratante debe proporcionar toda la información necesaria al paciente y a sus familiares directos, del proceso diagnóstico, terapéutico y pronóstico.

C. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y PROCEDIMIENTOS:

- Los exámenes y procedimientos deben tener relación y coherencia debida con la presunción diagnóstica.
- Los exámenes complementarios de chequeo médico, actividades preventivas o despistajes no relacionados con la patología de base o con síntomas reales no serán cubiertos.
- En caso de requerirse un examen o procedimiento que no pueda ser realizado en la clínica por falta de infraestructura o tecnología adecuadas y el paciente deba ser trasladado a otro centro, para su realización, los costos del traslado serán asumidos por la clínica tratante. Para los casos de provincias, el Médico Auditor del Financiador, maneja las particularidades, de mutuo acuerdo con el Proveedor.
- En la atención de Emergencia, los exámenes auxiliares y procedimientos deben estar orientados a la patología que motiva la atención, no debiendo realizarse estudios de ampliación diagnóstica o que correspondan a la atención ambulatoria.

D. TRATAMIENTO:

- El tratamiento médico o quirúrgico deberá tener relación directa y coherencia con el diagnóstico planteado y deberá tener sustento médico científico aceptado a nivel nacional e internacional.
- Será reconocido el uso profiláctico de antibióticos en los casos descritos y confirmados por la literatura científica médica internacional o nacional y su uso deberá ser acorde con las publicaciones validadas.
- El uso de antibióticos de últimas generaciones deberá ser debidamente sustentado por el Médico tratante y será sujeto a auditoría médica.

E. ESTANCIA HOSPITALARIA:

- Deberá estar en relación con los antecedentes clínicos y el motivo de ingreso, con tendencia a lograr los estándares internacionales, según la complejidad de la patología.
- Las estancias prolongadas (Ver Anexo de Estancia Hospitalaria) deberán ser debidamente sustentadas en la misma historia clínica y tendrán que tener informe del médico tratante e informe de auditoría de la Clínica y del médico auditor del Financiador.

F. ALTA DE LOS PACIENTES:

- Paciente hemodinámicamente estable, con enfermedad que motivó el ingreso diagnosticada, tratada o en tratamiento si es aguda, con franca evidencia de respuesta al tratamiento o compensada si es crónica.

3.2 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI):**3.2.1 DEFINICION**

- Es la unidad de internamiento para pacientes, de cualquier edad, que se encuentren en estado crítico, con posibilidad de recuperación parcial o total, que requieran para su supervivencia de servicios integrales de atención médica y de enfermería en forma permanente, además de equipos e instrumental que aseguren el adecuado control del tratamiento del paciente.

3.2.2 CRITERIOS DE INGRESO

- Para ingresar a un paciente a la UCI, el paciente debe encontrarse bajo el estado de síndromes clínicos graves y agudos, con inminencia de muerte, hemodinámicamente inestable o en post operatorio inmediato de cirugía mayor y / o complicada. Ver anexo “Guía de admisión y alta de la UCI”.

3.2.3 ALTA DE LOS PACIENTES DE LA UCI:

- Paciente hemodinámicamente estable.
- El alta de la UCI podrá ser programada durante cualquier día de la hospitalización, inclusive en el primer día, si las condiciones del paciente son las adecuadas.
- El alta de la UCI debe producirse cuando sea solucionado el o los criterios por los cuales el paciente fue internado en esta unidad.
- No se reconocerá días en la UCI para “observación” o sin justificación médica válida.
- Si el paciente debe continuar hospitalizado habiendo superado los estándares de estancia hospitalaria, esto deberá ser sustentado, durante la hospitalización, por el médico tratante, de acuerdo a las características clínicas de evolución científicamente válidas.

3.3 SALA DE REPOSO NO QUIRURGICO:**3.3.1 DEFINICION**

Definida en el inciso I.2.2.5 de las Normas de facturación.

3.3.2 CRITERIOS DE INGRESO

- Quimioterapia
- Transfusión sanguínea
- Litotripsia Extracorpórea
- Monitoreo fetal
- Hidratación Parenteral en Deshidratación moderada con intolerancia oral
- Paciente que por su estado clínico requiere observación
- Procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren anestesia general, regional, o sedación del paciente.

3.4 SERVICIOS QUIRURGICOS:**3.4.1. CRITERIOS DE INGRESO**

- Paciente que requiera intervención o procedimiento quirúrgico inmediato, salvo excepciones que deberán ser justificadas por el médico tratante.
- Cuando se trate de una operación electiva, el paciente deberá ingresar con estudio preoperatorio completo.

3.4.2 ALTA DE LOS PACIENTES:

- Paciente hemodinámicamente estable.
- Tratamiento oral o parenteral intramuscular.
- El alta podrá ser programada durante cualquier día de la hospitalización, inclusive en el primer día, si las condiciones del paciente son las adecuadas.
- El alta debe producirse cuando sea solucionado el o los criterios por los cuales el paciente fue internado en el servicio. No se reconocerán días adicionales para “observación” o sin plena justificación médica.
- Si el paciente debe continuar hospitalizado habiendo superado los estándares de estancia hospitalaria, esto deberá ser sustentado, durante la hospitalización, por el médico tratante al Financiador, de acuerdo a las características clínicas de evolución científicamente válidas.

**3.5 DEL PACIENTE EN ATENCION AMBULATORIA
/EMERGENCIA /PREVENTIVO PROMOCIONAL
/ODONTOLOGIA**

- Presentación de la Hoja de Solicitud de Beneficios, excepto en Emergencia, donde se regularizará en tiempo no mayor de 72 horas.
- Identificación del paciente con: carné del Financiador y DNI u otro documento de valor legal que presente fotografía actualizada.

VIII. GLOSARIO

Consulta Prolongada

Se define como aquella consulta en la que hay permanencia del médico tratante al lado de su paciente mayor a una hora.

Exclusión

Es un aspecto de la prestación que no será asumida por el Financiador. Las exclusiones son específicas y deben ser informadas al Proveedor.

Factor

Es el valor monetario variable, que según convenios, se asigna a las diferentes jerarquías de tarifas.

Financiador

Persona natural o jurídica responsable de la contratación de los Servicios de Salud vinculados a los Planes de salud o las Pólizas de Seguro contratadas.

Honorarios Médicos

El honorario médico se reconoce como la contraprestación económica que corresponde por un servicio específico brindado por el médico a su paciente.

Interconsulta

Se define como la atención brindada por un médico de una especialidad distinta a la del médico tratante, a solicitud de este último.

Manejo Conjunto

El manejo conjunto se define como la atención brindada simultáneamente por dos o más especialistas en virtud del estado del paciente, la afección múltiple de aparatos, órganos y/o sistemas que implica la concurrencia del conocimiento y experiencia de manejo de varias especialidades médicas.

Precio de la Prestación

Es el valor económico que resulta de multiplicar el factor por la unidad. Se expresa sin incluir el Impuesto General a las Ventas o cualquier otro impuesto que la grave.

Proveedor:

Persona natural o Jurídica encargada de brindar los servicios de salud vinculado con los Planes de Salud o las Pólizas de Seguro contratadas.

Tarifario

El tarifario es el instrumento técnico-normativo donde se consignan detallada e independientemente las prestaciones de salud que ofrece el Proveedor para todos los pacientes.

Está organizado por Especialidades Médicas y/o tipos de servicios. Cada prestación se encuentra codificada para su adecuada identificación.

El encabezado determina la jerarquía (Tarifas A, B, C, y otras) de organización de los procedimientos.

Los procedimientos serán comprendidos dentro de un grupo o encabezado de acuerdo con la naturaleza médica que le corresponde.

El Descriptivo de cada prestación define en líneas generales, el tipo de procedimiento del que se trata.

Cada prestación deberá consignar las unidades , y si son procedimientos quirúrgicos, la cantidad de días de estancia hospitalaria promedio, de carácter referencial, que requieran las entidades nosológicas o patologías; el número de ayudantes, si se requiere instrumentista y/o si se podrá disponer de estudios anátomo-patológicos.

Transferencia

La transferencia es la derivación del paciente de un médico tratante a otro, para su atención médica, temporal o definitiva.

Unidad

Es el valor técnico-administrativo constante, que corresponde para cada prestación de salud.

Uso de Equipo

Es el costo de la prestación al valor de reposición, desgaste, mantenimiento, renovación, pérdida tecnológica y los materiales e insumos propios de la manipulación de equipos médicos.

ANEXOS

ANEXO 1 AUDITORIA MEDICA: BASES LEGALES, ÉTICAS Y TÉCNICAS
LEY GENERAL DE SALUD 26842 (20 de julio de 1997)
LEY DE MODERNIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO DE ETICA DEL COLEGIO MEDICO DEL PERU (CMP)
LEY GENERAL DE SALUD 26842 (20 de julio de 1997)

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES CONCERNIENTES A LA SALUD INDIVIDUAL (TÍTULO I)

- Artículo 2.- Derecho a exigir que los bienes destinados a la atención de su salud correspondan a las características y atributos indicados en su prestación...
- g) A que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada sobre su proceso incluyendo el Diagnóstico, Pronóstico y alternativas de Tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos que se le prescriban y administran
- h) A que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a éste
- f) Cuando fuere proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de financiamiento vinculada con la atención prestada al paciente siempre que fuere con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría; y,
- g) Cuando fuere necesaria para mantener la continuidad de la atención médica al paciente.

DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES MÉDICAS

- Artículo 29.- El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado

CAPÍTULO II. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO

- Artículo 40.- Los establecimiento de salud y los servicios médicos tienen el deber de informar al paciente y familiares sobre las características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y condiciones del servicio, así como los aspectos esenciales vinculados con el acto médico.

DE LA AUDITORÍA MÉDICA

- Artículo 42.- Todo acto médico que se lleve a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible de auditorías internas y externas en las que puedan verificarse los diversos procedimientos a que es sometido el paciente, sean éstos para prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitar o realizar acciones de investigación.

CODIGO DE ETICA Y DEONTOLOGIA**TITULO VI DE LOS MEDICOS LEGISTAS Y AUDITORES**

- Art. 36° Los médicos legistas y médicos que realizan labores de auditoría médica, deben conformar sus actos a las normas establecidas en el presente Código.
- En sus informes, deberán limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular juicios de valor sobre la actuación de sus colegas o apreciaciones u opiniones que induzcan a terceros a comprometer la responsabilidad profesional de éstos.
- Art. 37° Los actos de los médicos legistas y auditores médicos que guarden relación con los actos médicos realizados por otro médico, se consideran de la misma naturaleza. Los actos realizados por los médicos legistas en el ejercicio de su actividad también se consideran actos médicos.
- Art. 38° Comete falta ética el médico auditor que actúa en perjuicio del médico o el paciente, sea manipulando las condiciones de las pólizas, planes o programas de prestaciones de salud o auditando superficialmente el caso o de cualquier otro modo demostrable.

DE LA PRESCRIPCION MEDICA

Art. 28° El médico es responsable del contenido de la receta o prescripción que expida.

- Art. 29° El médico tratante está facultado para prescribir el medicamento de su confianza. Toda prescripción deberá efectuarse por escrito, en forma clara y precisa, en recetario en el que deberá figurar el nombre del médico, su número de colegiatura y firma; así como el nombre del medicamento con su denominación común internacional y el nombre de marca de su elección, su forma de administración, el tiempo de tratamiento y la fecha de expedición.
- Art. 46° El médico, al solicitar los exámenes auxiliares que requiera para precisar su diagnóstico y establecer el pronóstico, debe evitar pedir exámenes que no sean de utilidad específica para este efecto, e indicar la terapéutica que corresponda, basada en conocimientos científicos actualizados y confirmados y teniendo en cuenta la condición económica del paciente.
- Constituye falta contra la ética indicar al paciente procedimientos diagnósticos o terapéuticos injustificados o que no correspondan a su problema de salud.
- Art. 51° El médico puede emplear justificadamente todos los procedimientos y tratamientos a su alcance cuando exista posibilidades de recuperar la salud del paciente. No es su obligación utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. En tales situaciones, debe considerar el empleo de medidas paliativas orientadas al alivio de la condición del paciente.

- Art. 52° Comete falta contra la ética, el médico que incurra en encarnizamiento terapéutico. Ha de entenderse por tal, la adopción de medidas terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso.
- El médico debe evitar una actitud de permisivismo ante la posibilidad de muerte del paciente o participar de algún modo en su provocación. Es deber del médico respetar el proceso natural del final de la vida y velar por una muerte digna de la persona enferma.
- Art. 74° Comete falta contra la ética el médico que modifique o adultere el contenido de la historia clínica, o de cualquier otro registro clínico relacionado con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún beneficio indebido para éste, para sí o para terceras personas.

DEFINICIÓN DE CALIDAD (OMS) :

- Alto nivel de excelencia profesional
- Uso eficiente de recursos
- Mínimo de riesgos para el paciente
- Alto grado de satisfacción por parte del paciente
- Impacto final en la salud

ANEXO 2**GUIA DE ADMISION EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS****RECOMENDACIONES DE ADMISIÓN A UCI**

Recomendaciones SCCM: (USA)

Prioridad 1: Pacientes inestables que exigen tratamiento intensivo.

Prioridad 2: Pacientes estables que exigen monitorización activa ó pueden hallarse en necesidad de tratamiento intensivo.

Prioridad 3: Pacientes que aún precisando tratamiento intensivo, tiene (por antecedentes, gravedad, reserva vital, etc) pocas posibilidades de beneficiarse de esta oferta.

Descartar los ingresos por causas administrativas ó presión social.

BIBLIOGRAFIA BASICA

1. ABC of Intensive Care. Criteria for Admission. Smith Gary, Nielsen Mick. BMJ 1999; 31: 8: 1544-1547
2. Criterios de Admisión Unidad de Terapia Intensiva. Sociedad Española de Medicina Crítica y Cuidados Coronarios. Congreso Español. 1998

ANEXO 3 DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA

El promedio de estancia en ausencia de complicaciones podría ser lo señalado en el listado. Estará sujeto a consenso entre Financiador y Proveedor, y será modificable según la revisión del Tarifario.

- **Parto Vaginal:** Dos (02) días.
- **Cesárea:** Tres (03) días.
- **Legrado Uterino:** Ambulatorio o 01 día.
- **Quiste Simple de Ovario:** Dos (02) días.
- **Histerectomía abdominal:** Cinco (05) días
- **Cirugía por distopia genital:** Tres (03) días.

- **Hemorroidectomía, Fisura Anal, Fístula Perianal o Absceso Perianal:** Ambulatoria o máximo dos (02) días si se operaron más de dos (2) paquetes hemorroidales.
- **Apendicectomía:** Hasta dos (02) días
- **Herniorrafia:** ambulatoria, las complicadas hasta dos (02) días
- **Colecistectomía Laparoscópica:** Dos (02) días post-cirugía
- **Colecistectomía Convencional:** Hasta cuatro (04) días.

- **Amigdalectomía:** Ambulatorio o 01 día
- **Tabique nasal desviado:** Ambulatorio o 01 día

- **Prostatectomía transuretral:** Tres (03) días.
- **Prostatectomía convencional:** Cuatro (04) días.

- **Diarrea aguda con criterio de internamiento:** Hasta dos (02) días.
- **Neumonía:** cuatro (04) días
- **Desorden vascular cerebral:** hasta cinco (05) días.
- **Asma con criterio de internamiento:** tres (03) días.
- **Celulitis:** tres (03) días
- **Trombosis Venosa Profunda:** hasta siete (07) días.
- **Diabetes con descompensación metabólica:** cuatro (04) días.
- **Hemorragia digestiva:** tres (03) días
- **Emergencia hipertensiva:** tres (03) días
- **Síndrome Isquémico Coronario Agudo:** hasta 06 días.
- **Insuficiencia cardíaca descompensada:** hasta 04 días.
- **Cólico Reno-ureteral:** Dos (02) días.

ANEXO 4: INDICACIONES PARA LA REALIZACION DE ELECTROENCEFALOGRAMA CON MAPEO CEREBRAL / SPECT CEREBRAL**1. INDICACIONES ESTABLECIDAS INTERNACIONALMENTE ACEPTADAS.**

- En epilepsia cuando se busca detectar crisis o spikes (espigas) durante el monitoreo electroencefalográfico prolongado o el registro ambulatorio de telemetría para facilitar la interpretación electroencefalográfica experta subsecuente.
- Para monitoreo EEG continuo en sala de operaciones o en sala de cuidados intensivos

2. INDICACIONES CONSIDERADAS COMO POSIBLEMENTE UTILES

- Como evaluación prequirúrgica en intervenciones para epilepsia
- En ciertos pacientes con síntomas de enfermedad cerebrovascular en quienes los estudios de imágenes y de EEG de rutina no son concluyentes. (Por ejemplo pacientes en quienes se está haciendo el diagnóstico diferencial entre una crisis y un ataque isquémico transitorio).
- En el estudio de pacientes con demencia.

3. INDICACIONES QUE PERMANECEN EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION

- Síndrome pos-tec o posconcusional, traumatismo encefalocraneano leve o moderado, problemas de aprendizaje, desórdenes por déficit de atención, esquizofrenia, depresión, alcoholismo, drogadicción.

4. NO RECOMENDADO

- Para su uso en procesos judiciales civiles o penales.

El Financiadore brindará cobertura para este examen en los casos incluidos en los acápite 1 y 2.

1. Nuwer Marc. Assessment of digital EEG, quantitative EEG, and EEG brain mapping: Report of the American Academy of Neurology and the American Clinical Neurophysiology Society. Neurology 1997; 49:277-292.

SPECT CEREBRAL

Con relación a las solicitudes del examen SPECT CEREBRAL es necesario señalar que se puede autorizar en los siguientes casos (**):

Detección de isquemia cerebral aguda: En las primeras 24 horas de UN ACV isquémico (*), cuando la TAC es normal y se necesita la certeza de diagnóstico de un infarto cerebral con el fin de decidir una conducta terapéutica.

- En pacientes con epilepsia, sólo como evaluación pre-quirúrgica para la detección del foco epileptógeno. Es decir, pacientes que sufren epilepsia (o convulsiones) de difícil tratamiento con medicamentos y se necesita estudios para determinar los lugares del cerebro donde e producen las descargas anormales que provocan las crisis y que podrían tener una solución o mejoría con una operación.
Es necesario indicar que en el resto de casos de epilepsia o conv'1islone~ su uso no se ha establecido. Sin embargo pueden existir casos aislados en donde el examen de SPECT pudiera ser de utilidad. Si el médico tratante así lo considera debe contactar con auditoría médica.

En pacientes con Enfermedad de Alzheimer probable, para contribuir a sustentar el diagnóstico.

En pacientes que han sufrido Ataques Isquémicos Transitorios (AIT o TIA) y se requiere definir la posibilidad de practicar una endarterectomía carotídea.

ANEXO 5:

MEDICINA HIPERBARICA

La cobertura está sujeta a la aprobación por el Financiador.

COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HIPERBARICA

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA

J. Desolaa, A. Crespob, A. Garcíaa, A. Salinasc, J. Salaa y U. Sánchezd
 aCRIS.-Unitat de Terapèutica Hiperbàrica. Hospital de la Creu Roja. Barcelona.
 bUnidad de Medicina Hiperbàrica JACRISSA. Clínica El Àngel. Màlaga.
 cUnidad de Terapia Hiperbàrica MEDIBAROX. Sanatorio del Perpetuo Socorro.
 Alicante.
 dUnidad de Medicina Hiperbàrica. Hospital Marqués de Valdecilla. Santander.

Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbàrica (CCCMH)
 European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM)

Publicado en JANO/Medicina
 Volumen LIV, nº 1260, 5-11 Junio de 1998.

INDICACIONES PREFERENTES

- Embolismo gaseoso (EG)
- Enfermedad por descompresión (ED)
- Síndrome de hiperpresión intratoràica (SHI)
- Mionecrosis clostridial-gangrena gaseosa (GG)

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS

- Infecciones necrosantes de partes blandas no clostridiales
- Traumatismos agudos de partes blandas, síndrome de aplastamiento y síndromes compartimentales
- Osteomielitis crónicas refractarias (OMCR)
- Retardos de cicatrización
- Algunos enfermos portadores de vasculopatías periféricas (arteriosclerosis, arteriopatía diabética, síndrome postrombótico, tromboangeítis obliterante, vasculitis por esclerodermia, isquemias postraumáticas) presentan trastornos tróficos de larga evolución, que persisten a pesar de haber agotado todos los recursos terapéuticos conservadores e invasivos.
- Otra situación también especial la constituyen los injertos y colgajos, que se implantan en territorios hipóxicos, irradiados e infectados, así como los reimplantes. En todas estas situaciones la hipoxia tisular en las primeras horas es la responsable de gran número de fracasos terapéuticos.
- Lesiones radioinducidas de hueso, partes blandas y mucosas

INDICACIONES EXPERIMENTALES:

EL FINANCIADOR NO CUBRE ESTE TIPO DE INDICACIONES

- Retinopatías oclusivas agudas (ROA)

- Sordera súbita (SS)
- Encefalopatía hipoxico-isquémica
- Esclerosis múltiple (EM)
- Enfermedad de Crohn

OTRAS INDICACIONES:**EL FINANCIADOR NO CUBRE ESTE TIPO DE INDICACIONES**

- Tanto el Comité de OHB de la Undersea & Hyperbaric Medical Society o su equivalente en el seno del European Committee for Hyperbaric Medicine, aceptan otras indicaciones complementarias o experimentales de la OHB, como la intoxicación por cianuro, las grandes anemias refractarias a transfusiones, el síndrome del gran quemado, la intoxicación por tetracloruro de carbono, la mucormicosis e incluso otras.
- No obstante, hemos preferido limitar esta revisión a las indicaciones en que disponemos de experiencia personal y podemos opinar con conocimiento de causa.

BIBLIOGRAFÍA

La publicación original incluye 24 referencias bibliográficas.

Marzo de 1998

Este documento ha sido obtenido de la página WEB del COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HIPERBARICA. Página WEB <http://www.CCCMH.com>